جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : حنان هليل يوسف عبد القادر
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** العياط **العنوان :** العياط
رقم البطاقة : 28107182100727 **رقم التليفون :** 01140545533 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 18-07-1981 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: حنان هليل يوسف عبد القادر
National ID: 28107182100727

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

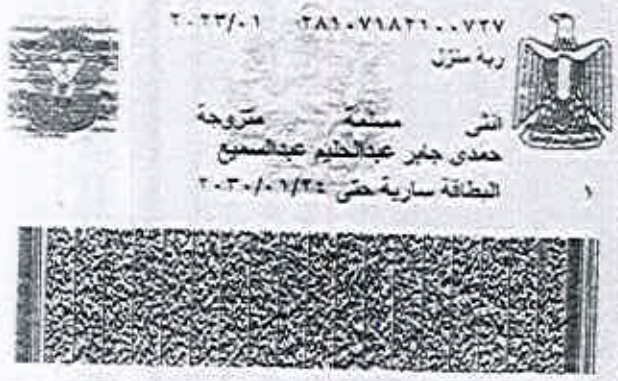
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL
EGYPT

Patient Name: Hanan Helail Youssef Abd Al Kader	Date : 30/08/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 44 Year(s)
Medical ID: 1399/2024	Pat. ID: 53667

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS

Clinical History:

- ***Known case of right breast cancer, compared to the previous study report dated 12-5-2024, the current study revealed:***

CT SCAN OF THE CHEST

Suboptimal study due to inadequate breast fields

Findings:



- Evidence of MRM with mild fat stranding yet no definite soft tissue mass lesions.
- No sizable right axillary lymph nodes.
- Few subcentimetric left axillary lymph nodes.
- Still noted right sided fissural based tiny nodules.
- Right upper and middle lobar atelectatic bands and subpleural reticulations, could be post radiotherapy sequel.
- Still noted few subcentimetric mediastinal lymph nodes.
- Patent tracheo-bronchial tree.
- Normal CT appearance of the mediastinal vessels.
- Average size of the heart.
- No evidence of pleural or pericardial effusion.

OPINION:

- ***Evidence of MRM with mild fat stranding yet no definite soft tissue mass lesions.***
- ***No sizable right axillary lymph nodes.***
- ***Few subcentimetric left axillary lymph nodes.***
- ***Still noted right sided fissural based tiny nodules.***
- ***Right upper and middle lobar atelectatic bands and subpleural reticulations, could be post radiotherapy sequel.***
- ***Still noted few subcentimetric mediastinal lymph nodes.***

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Name: حنان هليل يوسف عبد القادر\	
MR. : 2622	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 44-year-old individual with a history of right-sided invasive ductal carcinoma (IDC) of the breast, initially staged cT2N2M0. The tumor was hormone-receptor negative (ER 0/8, PR 0/8) and HER2-positive (HER2 3+). Neoadjuvant chemotherapy (NAC) with the TCHP regimen was administered, followed by a right mastectomy (MRM) in August 2024. Final pathology demonstrated a pathologic complete response (pCR) with ypT0 ypN0. The patient subsequently completed adjuvant anti-HER2 therapy and postoperative radiotherapy (PORT). Ongoing follow-up has shown no clinical evidence of recurrence; the most recent CT of the chest, abdomen, and pelvis in December 2025 was negative for disease, and the latest sonomammography in March 2026 revealed no local recurrence or new lesions. The patient remains without evidence of disease and continues routine follow-up.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : علياء احمد أبو النصر شهاب الدين

يعتمد ,

CT SCAN OF THE ABDOMEN AND PELVIS: -

Findings:



- The liver is mildy enlarged (15.2 cm) with diffuse low homogenous CT attenuation. No sizable focal lesions.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Average size of the spleen (10 cm) with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness and density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas and both suprarenal glands.
- Average filling of the urinary bladder with no sizable stones or masses.
- Still noted IUD.

Opinion:

- ***Fatty hepatomegaly for clinical and lab correlation.***

Marina Essam, MSc
Dr.Noura Nabil,MD

Signature Noura Nabil
04/09/2025 1:29 AM

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

ECHO REPORT

Name: هناء هلال

Date: 7 / 7 / 2025

EF	66.1	55-75%	PWT	0.9	0.6-1.1cm
LVEDD	4.5	3.5-5.8cm	AO.R	2.3	2-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	3.7	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3com(supine)
SWT	0.8	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions normal

LV wall thickness normal

LV diastolic function DD grade 1

SWMA no SWMA

LA and Ao root dimensions normal

Mitral Valve Trivial TR

Aortic valve normal

Tricuspid valve Trivial TR RVSP 25mmHg

Pulmonary valve normal

Right side and systolic function normal

Intracardiac masses and effusion -

Dr / Mina Adel

د/ مينا عادل

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hanan Helail Youssef Abd Al Kader	Date : 27/05/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 1399/2024	Pat. ID: 53667

BILATERAL BREASTS HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Report:

- Right breast multiple hypoechoic irregular masses are seen extending from 7 to 11 o'clock the largest is at 8 o'clock measuring 3.3 X 2.5 X 5 cm in maximum orthogonal dimensions seen about 3 mm from the skin, some of the lesions show intraductal extensions with the nearest one to the nipple is 1 cm away.
- No left solid or cystic mass lesions.
- Normal skin thickness.
- Normal nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Pathological right axillary level I single lymph node measuring 4 X 2.2 cm.
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.

Opinion:

- Right breast multicentric malignant process with pathological ipsilateral axillary lymph node BIRADS-6
- Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Mohamed Mohsen

27/05/2024 11:09 AM

Sonography
[[DOCTYPE:SONOGRAPHY]]

Patient Name	: الأستاذه / حنان هليل يوسف عبد القادر	Request No.	: 13007250
Patient No.	: 28107182100727	Request Date	: 11/05/2024
Path No.	: SR- 586/24	Verification Date	: 18/05/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data
Right breast mass

Nature of specimen
Slide &block revision

Gross examination
5 slides labelled by (3610) & one block were received
IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination
* Histological type: Invasive duct carcinoma , minimally represnted
* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+3+2) Grade III
* DCIS: No
* Angioinvasion: Couldn't be detected in the received biopsy
*Perineural invasion: No
• IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
* ER: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)
* PR: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)
* HER2: Strong complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (score 3+)

Diagnosis
Right breast mass, Slide revision:

Verified by :
Dr.Heba Hasan

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

atient Name	: الأستاذه / حنان هليل يوسف عبد القادر	Request No.	: 13007250
atient No.	: 28107182100727	Request Date	: 11/05/2024
ıth No.	: SR- 586/24	Verification Date	: 18/05/2024
ex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
ge	: 42 Y	Department	: Out Patient
eferreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

ıvasive duct carcinoma, Grade III minimally represnted.
ɔT:
ER: Negative (score 0/8).
PR: Negative (score 0/8).
HER2: Positive (score 3+).

Signature
Dr. Walaa Ghoneim Dr.Rana Fathy

Verified by :
Dr.Heba Hasan

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

PATIENT NAME: HANAN HELAYYEL YOSEF ABD EL KADER
GENDER: Female
DATE : 05-Jun-2024 06:33 PM

PATIENT ID: 10124242000
AGE: 42 y
ORDER: 2878029

CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY

INDICATION:
- Right 7-11 o'clock pathologically proven breast cancer

TECHNIQUE:
- Contrast Enhanced Spectral Mammography CC ahd MLO viewsultravist

REPORT:
- Contrast Enhanced Spectral Mammography showed mild symmetrical back ground parenchymal enhancement.
- Right UOQ and LOQ irregular mass lesions showing intense heterogenous mass enhancement with contiguous non-mass enhancement inbetween. The One at UOQ measures 4.6x4.2cm and the one at LOQ measures 7x4.5 cm. Non mass enhancement is seen extending from the LOQ lesion for a distance of 3.5cm to the nipple areola complex ending into two enhancing nodules located at the retroareolar region at a distance of <1cm from the nipple. The whole process occupies an area measuring 11x5cm and at a depth of 2 cm from the overlying skin.
- No left breast enhancing lesions or areas of non mass enhancement.

OPINION:
-Right multicentric malignanat process showing UOQ, LOQ and retroareolar mass and non-mass pathological enhancement as described (BIRADS 6).
- No left breast pathological mass or non mass enahncement (BIRADS 1)

Reported By,

Dr. Basma Alkalaawy, MD **05-Jun-2024 06:08 PM**

www.Baheya.org 16602
٤ شارع علوية نول شارع الهرم بجوار داري , الجيزة
٤ الحي الاول الشيخ زايد امام كلية الهندسة
Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

٢٦٢٩

Name : HANA HELIL YOUSEF	Date : 03-03-2026 12:22
Branch : Portable	Medical No. : GRI-030320266
Ref.Physician Prof :	Ins.Company :

Left Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Status post right MRM & ALAND, routine follow up.

Findings:

Left breast.

- Heterogeneously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Right mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections..
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.

Conclusion:-

Left breast (BIRADS 2): Diffuse breast adenosis.
Clear right mastectomy bed and axilla.

Recommendation:-

For annual follow up.

Best Regards,

DR. Amal Hegazi, M.Sc.

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]